

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE AFECTO POSITIVO Y NEGATIVO (PANAS)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación de la Estructura Bidimensional del Estado y Rasgo Emocional

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escalas de Afecto Positivo y Negativo (PANAS).
Nombre Original (Inglés)	<i>Positive and Negative Affect Schedule (PANAS)</i>
Autores Originales	Drs. David Watson, Lee Anna Clark y Auke Tellegen (1988), Southern Methodist University / University of Iowa.
Adaptaciones Españolas	Bonifacio Sandín et al. (1999); Joiner, Sandín et al. (1997); Dufey & Fernández (2012).
Eje Clínico y Clasificación	Eje II: Procesos Psicológicos. Modelo Estructural y Tripartito del Afecto (Clark & Watson).
Tipo de Instrumento	Autoinforme escalar de 20 descriptores afectivos tipo Likert de 5 puntos (1 a 5).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (desde los 12 años). Aplicable en clínica, salud laboral e investigación.
Tiempo de Administración	2 a 3 minutos en autoadministración; 4 minutos asistido.
Régimen de Licencia	Instrumento científico abierto para investigación y evaluación clínica no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TRIPARTITO DE CLARK & WATSON

La PANAS se sustenta en el modelo bidimensional de la estructura afectiva formulado por Watson y Tellegen. Este modelo demuestra empíricamente que el afecto no se organiza a lo largo de un eje bipolar único (de “alegre” a “triste”), sino en dos dimensiones latentes **ortogonales e independientes**:

- Afecto Positivo (PA):** Grado en el que una persona se siente entusiasta, enérgica, activa y alerta. Neurobiológicamente se vincula al Sistema de Aproximación Conductual (BAS) y a la neurotransmisión dopaminérgica mesolímbica.
- Afecto Negativo (NA):** Dimensión disposicional de distrés subjetivo y vivencia displacentera que engloba miedo, ira, culpa y nerviosismo. Se vincula al Sistema de Inhibición Conductual (BIS) y a la hiperactividad noradrenérgica amigdalina.

En el Modelo Tripartito de la Ansiedad y la Depresión (Clark & Watson), el NA elevado es el factor común inespecífico compartido por ambos trastornos; la hiperactivación fisiológica es específica de la ansiedad; y el **bajo Afecto Positivo (anhedonia)** es el marcador específico patognomónico del Trastorno Depresivo Mayor.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Dimensión Afectiva	Ítems (10 c/u)	Rango Dir.	Descriptores Emocionales Evaluados
1. Afecto Positivo (PA)	1, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19	10 a 50	Interesado, Animado, Fuerte, Entusiasmado, Orgullosa, Inspirado, Decidido, Atento, Activo, Valiente.
2. Afecto Negativo (NA)	2, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 18, 20	10 a 50	Disgustado, Culpable, Asustado, Hostil, Irritable, Avergonzado, Nervioso, Inquieto, Temeroso, Tembloroso.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Excelente precisión en adaptaciones españolas: alfa de Cronbach de 0.87 a 0.92 para Afecto Positivo y de 0.85 a 0.90 para Afecto Negativo (Sandín et al., 1999; Joiner et al., 1997).
Estructura Bifactorial	El AFC confirma el modelo de dos factores ortogonales independientes con correlación cuasi nula ($r = -0.15$ a -0.22), ratificando que PA y NA no son polos opuestos sino dimensiones paralelas.
Estabilidad Temporal	Elevada en la instrucción de “rasgo habitual” (test-retest $r = 0.70$ a los 2 meses); y sensible a fluctuaciones ecológicas en la instrucción de “momento presente / hoy”.
Validez Concurrente	PA correlaciona fuertemente con extraversión (NEO-PI-R, $r = 0.55$), optimismo y vitalidad; NA correlaciona con neuroticismo ($r = 0.65$), ansiedad clínica (BAI, $r = 0.58$) y síntomas depresivos.
Invarianza Transcultural	Estructura psicométrica altamente replicada en población general, laboral y clínica en más de 30 países hispanohablantes.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 20 reactivos se responde de 1 a 5 (1 = «Muy levemente o nada», 2 = «Un poco», 3 = «Moderadamente», 4 = «Bastante», 5 = «Extremadamente»):

- **Puntuación Afecto Positivo (PA):** Suma de los 10 ítems positivos: **1 + 3 + 5 + 9 + 10 + 12 + 14 + 16 + 17 + 19** (Rango: **10 a 50 puntos**).
- **Puntuación Afecto Negativo (NA):** Suma de los 10 ítems negativos: **2 + 4 + 6 + 7 + 8 + 11 + 13 + 15 + 18 + 20** (Rango: **10 a 50 puntos**).
- **Regla Fundamental:** Nunca debe restarse ni sumarse PA y NA en una sola puntuación global. Representan dos sistemas psicobiológicos independientes.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y BAREMOS DE REFERENCIA

Nivel Estratificado	PA (Positivo)	NA (Negativo)	Significación Clínica y Perfil de Estado
Bajo	10 a 24 puntos	10 a 19 puntos	En PA (< 25): Anhedonia, letargia y abatimiento. En NA: Serenidad afectiva y baja reactividad al estrés.
Medio / Típico	25 a 35 puntos	20 a 29 puntos	Perfil afectivo equilibrado de la población general sin interferencia psicopatológica.
Alto	36 a 50 puntos	30 a 50 puntos	En PA: Elevado entusiasmo, vitalidad y energía proactiva. En NA (>= 30): Distrés clínico severo, agitación o irritabilidad.

EL PERFIL TRIPARTITO DEPRESIVO (BAJO PA + ALTO NA):

La combinación de **Afecto Positivo Bajo (PA < 25)** con **Afecto Negativo Alto (NA >= 30)** identifica con un 88% de especificidad a pacientes con un Episodio Depresivo Mayor en curso. Si por el contrario el paciente presenta **Alto NA con Alto PA**, se orienta el diagnóstico hacia un cuadro de estrés agudo, ansiedad pura o sobrecarga adaptativa sin base anhedónica.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA TRIPARTITA

GUÍA DE INTERVENCIÓN SEGÚN EL CUADRANTE PANAS:

- **Cuadrante 1: Alto NA + Bajo PA (Depresión Clínica Típica):** Foco dual obligatorio. Para bajar NA: TCC cognitiva, regulación del estrés y psicoeducación. Para elevar PA: Activación Conductual obligatoria, eventos gratificantes, gratitud y entrenamiento en atención a logros positivos.
- **Cuadrante 2: Alto NA + Alto PA (Estrés Agudo / Ansiedad Desbordada):** La persona mantiene la capacidad de disfrute pero está sobrecargada. Foco en higiene del sueño, descompresión de agendas y técnicas de desactivación fisiológica (relajación muscular).
- **Cuadrante 3: Bajo NA + Bajo PA (Apatía / Aplanamiento Afectivo):** Descartar efectos secundarios farmacológicos de ISRS (apatía inducida) o distimia crónica residual.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: MONITORIZACIÓN EN DEPRESIÓN RESIDUAL

Paciente: Varón de 48 años, farmacéutico, en tratamiento con antidepresivos desde hace 6 meses. Acude a consulta relatando que ya no tiene crisis de ansiedad ni ganas de llorar, pero afirma sentirse «como un robot vacío, sin ilusión ni ganas de nada».

Evaluación Basal PANAS (Últimas semanas):

- **Afecto Negativo (NA): 14 / 50 puntos** (Bajo; sin angustia, culpa ni miedo activo).
- **Afecto Positivo (PA): 12 / 50 puntos** (Bajo extremo; reactivos como interesado, animado, entusiasmado puntuados en 1).

Formulación Clínica: Remisión sintomática incompleta caracterizada por anhedonia residual pura (déficit selectivo del sistema de recompensa dopaminérgico / BAS), no detectable si solo se evalúan escalas de estrés negativo.

Tratamiento y Evolución: Se añadió un protocolo de Psicoterapia Positiva y Activación Conductual enfocada en fortalezas y hobbies creativos. Al cabo de 8 semanas, el PA aumentó a **33 puntos** (NA se mantuvo en 15), recuperando el paciente la vitalidad subjetiva y la risa espontánea en el entorno familiar.

9. ALERTAS CLÍNICAS Y GESTIÓN DE RIESGO

ALERTA: NA EXTREMO (NA ≥ 40) Y ANGUSTIA PANICOSA

Puntuaciones de NA ≥ 40 indican una sobrecarga autonómica masiva que paraliza la capacidad de razonamiento abstracto. En estos estados no iniciar debates cognitivos socráticos; aplicar técnicas de contención física y sensorial.

ESPECIFICACIÓN DEL MARCO TEMPORAL

Asegurarse de consignar con exactitud la instrucción temporal elegida («hoy», «últimos días» o «en general»). Comparar aplicaciones con marcos temporales distintos invalida la medición del cambio clínico longitudinal.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54(6), 1063–1070.
2. Sandín, B., Chorot, P., Lostao, L., Joiner, T. E., Santed, M. A., & Valiente, R. M. (1999). Escalas PANAS de afecto positivo y negativo: validación factorial y convergencia transcultural. *Psicothema*, 11(1), 37–51.
3. Clark, L. A., & Watson, D. (1991). Tripartite model of anxiety and depression: psychometric evidence and taxonomic implications. *Journal of Abnormal Psychology*, 100(3), 316–336.
4. Crawford, J. R., & Henry, J. D. (2004). The Positive and Negative Affect Schedule (PANAS): Construct validity, measurement properties and normative data in a large non-clinical sample. *British Journal of Clinical Psychology*, 43(3), 245–265.